



Pasuruan, 21 Oktober 2025

Nomor : 905/RSPHS/I-UND/DIR/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Unit

Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Umum dan Keuangan
2. Kepala Unit Asuransi Center
3. Seluruh Staf Asuransi Center

di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan **Rapat Koordinasi Asuransi Center** di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada :

Hari / tanggal : Rabu / 22 Oktober 2025
Pukul : 14.00 - selesai
Tempat : Ruang Meeting Sekretariat
Kegiatan : Rapat Koordinasi Unit

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Plt Direktur RS Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari S.Kep,M.Kep



Materi rapat

1. Kasus stomatitis
2. Kasus orif pada ortho
3. Kasus flap
4. Kasus oedema paru
5. Kasus dhf
6. Kasus rekonstuksi facial bone
7. Appendik adhesiolisis
8. Effuse pleura
9. Synovectomy
10. Maxsilektomi
11. Hemiplegia
12. 1hari rujuk
13. Kendala asuransi swasta



RSPHSKR
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO
KAB. PASURUAN
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir
RAPAT OKTOBER 2025 - ASURANSI CENTER

Tempat : R MEETING SEKRETARIAT
Location :

Tanggal dan : Rabu, 2025-10-22 14:00:00
Jam :
Date Time : Wed, 2025-10-22 14:00:00

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	Maya Agustina, A.Md Kes	RS Prima Husada Sukorejo	Asuransi Center		
3	Rekha Himarodianti, A.Md RMIK	Asuransi center	karyawan		
4	Putri Eka Pratiwi, A.Md RMIK	Asuransi Center	pelaksana		
5	Nida Nur Hidayatus Surya, A.Md Kes	Asuransi Center	Pelaksana		
6	Aprilia Rose Mawati, A.Md Kes	RS Prima Husada Sukorejo	Perekam Medis		
7	Ratih Rahmawati, S.Tr.RMIK	RS Prima Husada Sukorejo	Perekam Medis		
8	Iga imania	Asuransi center	PESERTA		
9	Iga imania	Asuransi center	PESERTA		
10	Vany Nur Awalini A.Md. RMIK	Asuransi Center	PESERTA		
11	Rhizqita JuliN Eka Rahmanda. AMd.PK.SKM	Asuransi center	PESERTA		
12	Prisna sandy faradilla	Asuransi center	PESERTA		
13	Hanik amalia	Asuransi center	PESERTA		
14	Agustin Rahmawati, A.Md RMIK	Asuransi Center	Rekam Medis (Asuransi Center)		

NOTULEN

HARI / TANGGAL : 22 Oktober 2025
 PUKUL : 14.00
 JENIS MEETING : Rapat Bulanan
 TEMPAT : Asuransi Center

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : temuan audit SPI kasus stomatitis Masalah : 1. Diagnose stomatitis menggunakan K12.0 temuan SPI nasional 2. Secara kaidah koding kode stomatitis K12.1 sudah sesuai namun temuan SPI untuk stomatitis menggunakan kode K12.0 (temuan nasional) Keterangan : PIC : 1. Asuransi center Rencana Tindak Lanjut : 1. Bila didapatkan diagnose stomatitis maka harus spesifik stomatitis apa yang tegak diagnosanya 2. Bila hanya stomatitis saja maka lakukan koordinasi dengan dpjp untuk stomatitis yang lebih spesifik 3. Tatalaksana dan klinis yang spesifik yang diberikan apa harus jelas dan tertulis pada resume medis
2	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI orif pada ortho Masalah : 1. Tindakan close reduction di koding open reduction PIC : 1. Asuransi center Rencana Tindak Lanjut : 1. Pada audit wasin yang ada terdapat 2 tindakan yaitu orif dan close reduction 2. Kodingan sudah sesuai 3. Kedepan pastikan kembali tindakan apa yang dilakukan orif atau close reduction 4. Pastikan stiker implan terpasang pada laporan operasi bila dilakukan orif 5. Cek kembali kodingan orif sesuai dengan regio yang di lakukan 6. Penunjang lampirkan bila pada hasil radiologi tidak menunjukkan fraktur maka koordinasi dengan DPJP untuk memberikan penandaan pada basahan foto dan Prkan ke ruangan untuk dilakukan koordinasi dengan radiologi menggunakan form expertice dpjp
3	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI Flap Masalah : 1. Dari temuan SPI Kasus flap pada STT mengguakan radical excision of skin (86.4) bukan menggunakan advancement flap (86.4) PIC : Asuransi center Rencana Tindak Lanjut : 1. Untuk kasus flap pada STT mmenggunakan kode 86.4 karena pasti dilakukan eksisi dahulu tidak langsung flap 2. Kodingan excision dan flap include yaitu 86.4 3. Untuk tindakan flap yang luas maka dapat digunakan, contohnya seperti pada kasus kll dan harus di gambar untuk flapnya ambil dari organ lain atau bagaimana (graf dan flap)
4	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI odema paru Masalah : Dari temuan SPI kasus edema paru nilai HR harus >100 dan hanya dilihat dari keluaran EKG



	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Untuk penegakan diagnosa edema paru maka HR harus di pastikan nilai >100 (pada hasil EKG) dan klinis harus sesuai dengan ketentuan di BA 2. Bila nilai HR pada EKG <100 maka edema paru tidak dapat ditegakkan 3. Surat edaran sudah ada
5	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus DHF
	Masalah : Diagnosa DHF tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan Nilai hematokrit tidak menunjukkan kenaikan sebesar 20%
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Pastikan kembali diagnosa DHF harus sesuai dengan PNPk 2. Klinis DHF harus sesuai dengan ketentuan PNPk bila terdapat salah satu tidak sesuai maka tidak bisa 3. Pastikan kembali kenaikan/penurunan hematokrit sesuai dengan ketentuan demografi usia yang tertera pada PNPk
6	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus rekonstruksi facial bone
	Masalah : Temuan BPJS kesehatan penulisan tindakan rekonstruksi facial bone pada laporan operasi tidak tertulis stepnya sehingga langkah yang dilakukan oleh dpjp seperti orif mandibula/orif maksila
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Untuk tindakan rekonstruksi facial bone seharusnya ditulis step by step yang jelas sehingga terlihat tindakan apa yang dilakukan → koordinasi dengan DPJP 2. Untuk kedepan menggunakan tindakan orif mandibula/maksila
7	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus appendic adhesiolisis
	Masalah : Temuan BPJS kesehatan tindakan appendectomy dengan adhesiolisis merupakan satu kesatuan karena perlengketan disekitar appendiknya, kecuali bila perlengketan di organ lain maka dapat digunakan (misal dengan pankreas)
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : Bila terdapat tindakan appendectomy dengan adhesiolisis maka hanya dikoding hanya appendectomy saja
8	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus effusi pleura
	Masalah : Temuan BPJS kesehatan effusi pleura pada kasus neoplasma tidak dilakukan pemeriksaan analisa cairan
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Bila terdapat effusi pleura pada kasus neoplasma maka wajib dilakukan pemeriksaan sitologi cairan pleuranya 2. Koordinasi dengan kabid dan direktur untuk dibuatkan SE



9	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus synovectomy
	Masalah : Temuan BPJS kesehatan pengkodean sinovectomy tidak sesuai
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : Tindakan eksisi kista baker pakai 83.39
10	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus maxsilectomy
	Masalah : Temuan BPJS kesehatan tindakan mexilectomy parsial pada sinusitis maxila menggunakan 22.62 (edmoidectomy)
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : Tindakan rekonstruksi maxsila menggunakan 22.62 Fess menggunakan 22.9
11	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus hemiplegia
	Masalah : diagnosa cva trombo dan cva emboli dengan hemiplegia, untuk hemiplegia include dengan diagnosa cva trombo/embolinya
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Bila terdapat cva trombo/emboli terdapat hemiplegia maka koding sebagai cva trombo/emboli saja 2. pada resume harus dituliskan nilai motoriknya berapa 3. kode spesifik hemiplegia harus di tuliskan sesuai dengan INADRG
12	Pokok Bahasan : temuan kasus SPI kasus 1 hari rujuk
	Masalah : Ditemukan kasus pasien 1hari kemudian di rujuk karena rs tidak memiliki pelayanan yang dibutuhkan
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : Untuk kasus dimana sejak awal pasien di advicekan untuk dirujuk maka klaimnya adalah rawat jalan
13	Pokok Bahasan : ketidak sesuaian antara diagnosa dan penunjang
	Masalah : Ketidak sesuaian diagnosa, klinis dan penunjang
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. bila ditemukan diagnosa, klinis dan pemeriksaan penunjang tidak sesuai maka koordinasikan dengan dpjp 2. sesuai dengan SE maka dpjp harus berkoordinasi dengan dokter penunjang medis 3. ada form komunikasi di ruangan untuk membantu berkoordinasi antar dpjp dan dokter penunjang
14	Pokok Bahasan : kendala admin jaminan jkk
	Masalah : 1. tarif JKK faktur harus dilampirkan 2. tarif implan di billing belum sesuai dengan ketentuan JKK
	PIC : Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut : 1. sementara dilakukan rekap manual dahulu 2. FU ulang ke mbk noven untuk di Fukan ualng ke prograimer

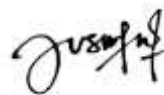
	3. bila ada kesalahan inputan baik dari RS maupun dari jkk/aplikasi bermasalah oleh jkk klaim akan dipending semua bukan hanya yang bermasalah saja yang di pending
15	Pokok Bahasan : inhouse klinik
	Masalah : Setiap inhouse klinik terdapat ketentuan yang berbeda sehingga untuk pengklaiman harus menunggu kelengkapan dari perusahaan
	PIC : Asuransi center Humas
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Lakukan FU berkala kepada humas untuk meminta kelengkapan yang diperlukan untuk klaim 2. Humas harus meminta kelengkapan berkas kepada perusahaan segera sebelum berangkat untuk klaim yaitu tgl 5 hari berikutnya (misal surat jalan, PO, BAP kepada perusahaan) 3. Sebelum berangkat klaim harus dilakukan pengecekan dengan humas untuk sinkronasi data → master data di humas
16	Pokok Bahasan : MIH
	Masalah : Klaim obat MIH (simo) tidak diinputkan secara langsung oleh farmasi penginputan di lakukan kolektif
	PIC : Asuransi center Kabid penunjang
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dengan kabi penunjang untuk dilakukan penginputan obat MIH di simo sama seperti penginputan di apol (dilakukan setiap ada pasien) 2. Admin jaminan selalu melakukan FU kepada farmasi agar dapat dilakukan penginputan segera setelah pasien mendapatkan pelayanan
17	Pokok Bahasan : Kendala admin jaminan
	Masalah : kurangnya komunikasi bila terjadi masalah
	PIC : Admin jaminan
	Rencana Tindak Lanjut : 1. Bila ada kendala segera dikomunikasikan jangan sampai menunggu masalah menjadi besar 2. Bila terdapat komunikasi pihak luar maka tuliskan di form komunikasi, isi komunikasi nama yang di tlp, jam dan tgl serta komunikasi by apa 3. Kelengkapan dokumen klaim wajib di cek sebelum klaim berangkat

Pemimpin Rapat

Pasuruan, 22 Oktober 2025
Notulis



(Rhizqita Julian Eka R Amd.PK SKM)



(Nida Nur Hidayatus Surya, Amd.Kes)

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S. Kep, Ns, M.Kep)

DOKUMENTASI

